Клинические рекомендации

Рак полости носа и придаточных пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C30** — Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха **C31** — Злокачественное новообразование придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/3_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 3

2.4 Классификация TNM (8-е издание, 2017) 3

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы, анамнез и осмотр 5

3.3 Биопсия слизистой оболочки полости носа 5

3.4 КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ 5

4. Лечение 5

4.1 Рак полости носа и клеток решётчатого лабиринта 5

4.2 Рак верхнечелюстной пазухи (кроме меланомы, саркомы, лимфомы) 6

4.3 Лучевая терапия 6

4.4 Хирургическое лечение 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7

5.1 Диспансерное наблюдение 7

5.2 Организация медицинской помощи 7

6. Источник и актуальность **7**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Рак полости носа и придаточных пазух — злокачественная опухоль из элементов слизистой оболочки полости носа и пазух; 1,4% всех злокачественных опухолей.
- Повод заподозрить рак — заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**; первые проявления также выделения из носа, боль, экзофтальм при распространении в орбиту.
- Ранний рак решётчатого лабиринта в большинстве случаев выявляют при гистологическом исследовании материала после операций по поводу предполагаемых неопухолевых процессов (полипозный этмоидит, полипы полости носа).
- Всем — биопсия слизистой оболочки полости носа; распространённость — КТ лицевого черепа и шеи с контрастированием и (или) МРТ, УЗИ лимфоузлов шеи.
- При подозрении на рак пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация — **не позднее 5 рабочих дней**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Верхняя стенка полости носа представлена сетевидной (решётчатой) пластинкой, передней стенкой основной пазухи, передними клетками решётчатого лабиринта; внутренняя — перегородкой носа; наружная — медиальной стенкой верхнечелюстной пазухи; задняя — хоанами; передняя — грушевидным отверстием.

Радикальная операция (R0) — удаление поражённого органа в пределах здоровых тканей вместе с зонами регионарного метастазирования без остаточных проявлений опухолевого процесса.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. хронические воспалительные заболевания: хронические синуситы, вазомоторный ринит, бронхиальная астма, инвертированная папиллома;
2. неблагоприятные факторы внешней среды;
3. канцерогены физической и химической природы, особенно на вредном производстве.

Злокачественные опухоли полости носа и пазух составляют 1,4% всех злокачественных опухолей; в 2021 г. в России — 1012 новых случаев.

2.3 Клиническая картина

В 70% случаев опухоли эпителиальные: плоскоклеточный рак — 80%, аденокарцинома — 6%, эстезионейробластома — 10%, редко меланома.

Первые проявления

1. заложенность носа;
2. выделения из полости носа;
3. болевой синдром;
4. экзофтальм при распространении в орбиту.

2.4 Классификация TNM (8-е издание, 2017)

Символ T: верхнечелюстная пазуха

T	Верхнечелюстная пазуха
T1	ограничена слизистой оболочкой без эрозии или деструкции кости
T2	эрозия или разрушение кости, включая твёрдое нёбо и (или) средний носовой ход, без распространения на заднюю стенку пазухи и крыловидные отростки
T3	задняя стенка пазухи, подкожная клетчатка, дно или медиальная стенка орбиты, крыловидная ямка, решётчатые клетки
T4a	передний край орбиты, кожа щеки, крыловидные отростки, подвисочная ямка, сетевидная пластинка, основная или лобная пазуха
T4b	купол орбиты, твёрдая мозговая оболочка, мозг, средняя черепная ямка, черепные нервы (кроме верхнечелюстной ветви тройничного), носоглотка, скат

Символ T: полость носа и решётчатый лабиринт

T	Полость носа, клетки решётчатого лабиринта
T1	одна сторона полости носа или решётчатых клеток, с эрозией кости или без
T2	две стороны полости носа и прилежащие участки в пределах полости носа и решётчатых клеток
T3	медиальная стенка или дно орбиты, верхнечелюстная пазуха, нёбо, решётчатые клетки
T4a	передние структуры орбиты, кожа носа или щёк, минимально передняя черепная ямка, крыловидные отростки, основная или лобная пазуха

1. **N1** — один ипсилатеральный лимфоузел до 3 см без экстракапсулярной инвазии
2. **N2** — до 3 см с ENE+ или 3–6 см ENE−; несколько ипсилатеральных или контралатеральные до 6 см ENE−
3. **N3** — более 6 см ENE− или любой с ENE+ кроме N2a

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I / II / III	T1N0 / T2N0 / T3N0 или T1–T3N1
IVA	T4a N0–N2; T1–T3 N2
IVB	любая T N3; T4b любая N
IVC	M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: заложенность носа, не поддающаяся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. осмотра и пальпации образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологии соскоба, мазков, пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. патологоанатомического исследования биопсийного материала;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, КТ лицевого черепа и шеи с контрастом и (или) МРТ, ПЭТ-КТ, фиброларингоскопия по показаниям.

3.2 Жалобы, анамнез и осмотр

Всем — тщательный сбор жалоб и анамнеза для выбора тактики лечения.

Всем — осмотр и бимануальная пальпация очага и регионарных лимфоузлов, оценка нутритивного статуса.

3.3 Биопсия слизистой оболочки полости носа

Всем — биопсия слизистой оболочки полости носа. При верифицированной опухоли определяют гистологический тип и степень дифференцировки.

При сомнительном результате обязательна повторная биопсия в достаточном объёме с иммуногистохимией; при повторно отрицательном результате биопсию повторяют при убедительных клинических и (или) рентгенологических признаках злокачественной опухоли.

3.4 КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ-КТ

Всем — КТ лицевого черепа и шеи с болюсным контрастированием и (или) МРТ лицевого черепа и шеи с контрастом.

Стадирование

1. УЗИ лимфоузлов шеи и тонкоигольная биопсия изменённых узлов под УЗИ или КТ;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. КТ органов грудной полости (при невозможности — рентгенография лёгких);
4. при T3–T4 или N1 и более — ПЭТ-КТ или КТ грудной и брюшной полостей с контрастом;
5. фиброларингоскопия и ЭГДС по показаниям.

Через **2–3 месяца** после ЛТ или ХЛТ — ПЭТ-КТ с ФДГ или МРТ с контрастом для оценки эффекта.

В заключении по операционному материалу отражают

1. размер, глубину инвазии, гистологическое строение и дифференцировку;
2. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
3. pT, pN с числом исследованных и поражённых узлов и экстранодальным распространением;
4. состояние краёв резекции.

---

4. Лечение

4.1 Рак полости носа и клеток решётчатого лабиринта

Лечение рака полости носа и решётчатого лабиринта

Ситуация	Рекомендованное лечение
T1–T2, первично выявленный	операция, после неё ЛТ; наблюдение — только при T1 с благоприятными признаками (чистые края, нет прилежания к сетевидной пластинке и медиальной стенке орбиты, высокая дифференцировка)
T3–T4a	операция на первом этапе, или ЛТ/ХЛТ, или индукционная ХТ с операцией или ХЛТ; после операции — ЛТ или ХЛТ при опухоли в краях резекции и (или) внутричерепном распространении
T4b, отказ от операции, противопоказания	по ECOG: 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 — ЛТ ± ХТ; 3 — паллиативная ЛТ, монохимиотерапия или паллиативная помощь

Если диагноз установлен после неполного удаления (полипэктомия) и есть остаточная опухоль — хирургическое удаление, ЛТ или конкурентная ХЛТ; без видимой остаточной опухоли — ЛТ или операция, затем ЛТ. Наблюдение — только при T1 и благоприятных признаках.

Нерадикальная первая операция фактически является расширенной биопсией, и дальнейшее лечение проводят как при впервые установленном диагнозе. Метастазы в лимфоузлы шеи при раке полости носа и решётчатого лабиринта крайне редки; при их выявлении выполняют шейную лимфодиссекцию.

При синоназальной недифференцированной карциноме, низкодифференцированной эстезионейробластоме, синоназальном нейроэндокринном раке в план включают системную химиотерапию.

4.2 Рак верхнечелюстной пазухи (кроме меланомы, саркомы, лимфомы)

Лечение рака верхнечелюстной пазухи

Ситуация	Рекомендованное лечение
T1–T2 N0 (кроме аденокистозного рака)	радикальная операция и наблюдение; при периневральной, сосудистой, лимфатической инвазии — ЛТ или ХЛТ; при положительных краях — перезекция и ЛТ
T1–T2 N0, аденокистозный рак	радикальная операция и ЛТ; наблюдение — при R0 и отсутствии периневральной инвазии
T3–T4a N0	радикальная операция, затем ЛТ; при опухоли в краях резекции — ХЛТ
T1–T4a N+	удаление опухоли и расширенная шейная лимфаденэктомия, затем ЛТ; при опухоли в краях или экстракапсулярном распространении — ХЛТ
T4b, отказ от операции	по ECOG: 0–1 — ХЛТ или индукционная ХТ с ЛТ; 2 — ЛТ ± ХТ; 3 — паллиативное лечение

1. **рецидив без предшествующей ЛТ** — операция, ХЛТ или индукционная ХТ с ХЛТ
2. **рецидив после ЛТ** — операция с обсуждением повторной ЛТ; при невозможности операции — повторная ЛТ и противорецидивная ХТ
3. **рецидив с отдалёнными метастазами** — по ECOG, как при T4b

4.3 Лучевая терапия

1. **самостоятельная ЛТ** — на опухоль и метастазы в лимфоузлах 70 Гр (1,8–2,0 Гр за фракцию) **7 недель**, на неизменённые лимфоузлы 50 Гр
2. **послеоперационная ЛТ** — на ложе опухоли и поражённые узлы 60–66 Гр, на неизменённые узлы 50 Гр; интервал после операции **до 6 недель**, **не более 3 месяцев**

Послеоперационная ХЛТ: 66–70 Гр за 6–7 недель с цисплатином 100 мг/м² в 1, 22 и 43-й дни (или еженедельно); при противопоказаниях к препаратам платины (СКФ менее 50–60 мл/мин, возраст старше 65 лет, ECOG более 1) — цетуксимаб.

Паллиативная ЛТ — для облегчения симптомов при невозможности радикального лечения: 50 Гр по 2,5 Гр или 30 Гр по 3 Гр.

Индукционная ХТ — доцетаксел + цисплатин + фторурацил, 2–3 курса через 3 недели; при нейроэндокринной опухоли и эстезионейробластоме — схемы с этопозидом. Противорецидивная поли- или монохимиотерапия, иммунотерапия — по общему состоянию; режимы — в таблице КР.

4.4 Хирургическое лечение

Всех пациентов до лечения оценивают хирург и онколог, специализирующиеся на опухолях головы и шеи. Первичную опухоль удаляют единым блоком с чистыми краями; чистый край — 5 мм и более от инвазивного края опухоли. При прилежании опухоли к нерву — резекция нерва со срочным гистологическим исследованием краёв.

Плохой прогноз (неоперабельность): значительное поражение крылонёбной ямки, тяжёлый тризм из-за инфильтрации крыловидных мышц, распространение на основание черепа, охват сонной артерии на 270° и более, распространение на кожу, средостение, предпозвоночную фасцию.

При угрозе кровотечения из опухоли — оценка риска, ангиография и суперселективная эмболизация сосудов опухоли.

Всем — реабилитация по общим принципам после операций и химиотерапии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Частота осмотров после лечения

1. 1–2-й год — **каждые 3–6 месяцев**;
2. 3–5-й год — **1 раз в 6–12 месяцев**;
3. после 5 лет — ежегодно или при жалобах.

Обследование

1. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон: **каждые 3 месяца** в 1-й год, каждые 3–6 месяцев во 2-й, ежегодно в 3–5-й;
2. КТ или МРТ лицевого черепа и шеи: каждые 3 месяца в 1-й год, 3–6 месяцев во 2-й, далее по показаниям;
3. КТ органов грудной полости каждые 12 месяцев;
4. фиброларингоскопия и ЭГДС при жалобах; при подозрении на рецидив — ПЭТ-КТ.

5.2 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи; консультация — **не позднее 5 рабочих дней**, патологоанатомическое исследование — **не более 15 рабочих дней**. Тактику лечения определяет онкологический консилиум.

Факторы прогноза

1. размер и распространённость опухоли, дифференцировка;
2. периваскулярная, перилимфатическая, перineвральная инвазия;
3. метастазы в лимфоузлах шеи (вдвое снижают выживаемость), экстранодальное распространение;
4. индекс Ki-67, статус краёв резекции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак полости носа и придаточных пазух»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 24.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	3_2 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Периодичность наблюдения в разделах 2.4.3 и 5 различается: в 2.4.3 УЗИ шеи — каждые 3 месяца в 1-й год и ежегодно в 3–5-й, в разделе 5 — каждые 3–6 месяцев; осмотры в 1–2-й год указаны как «каждые 36 месяца» (вероятно, 3–6).